



LightCOM

Lighthouse Consortium on
Obesity Management

Study name: **Lighthouse Consortium on Obesity Management**
Short name: **LightCOM**

SOP title: **Standard Operating Procedure for handling of biochemistry
and DXA-results in relation to CIDs in LightCARE and
LightWAY.**

SOP short title: **SOP on biochemistry and DXA-results**

SOP Version: **1** Date: **12.02.2025**

Authored by: **Carsten Dirksen** Date: **30.01.2025**
Olivia Duun

TABLE OF CONTENTS

1	NAME OF PROCEDURE:	2
2	PURPOSE AND APPLICABILITY.....	2
3	PERSONNEL QUALIFICATIONS AND RESPONSIBILITIES	2
4	EQUIPMENT AND RESOURCES	2
4.1	Equipment	2
4.2	Forms.....	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
4.3	Other Resources	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
5	HEALTH AND SAFETY	2
6	PROCEDURE.....	3
6.1	Arbejdsgang.....	3
6.2	Handlegrænser.....	3
7	EXPECTED RESULTS, TROUBLESHOOTING AND CORRECTIVE ACTION ..	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
8	REFERENCE	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
9	CHANGE HISTORY	4

1 NAME OF PROCEDURE:

Standard Operating Procedure for handling of biochemistry and DXA-results in relation to CIDs in LightCARE and LightWAY.

2 PURPOSE AND APPLICABILITY

Dette dokument angiver procedure for håndtering af prøvesvar i forbindelse med CIDs for deltagere i LightCARE og LightWAY. Deltagerne vil få taget blodprøver og urinprøver ved alle fire CIDS og vil ved CID1, 3 og 4 også få udført en DXA-scanning.

3 PERSONNEL QUALIFICATIONS AND RESPONSIBILITIES

Læge ansat på LightCOM.

4 EQUIPMENT AND RESOURCES

4.1 Equipment

Access to SP.

5 HEALTH AND SAFETY

N/A

6 PROCEDURE

Deltagere fra LightWAY/CARE skal som minimum have svar på biokemi og DXA-scanning i henhold til fastsatte handlegrænser (se skema nedenfor). Den læge, som ser svar, kan dog vurdere, at der er behov for at kontakte patient selvom værdierne er indenfor handlegrænserne. Ved behov for svar sendes der en besked til deltageren via MinSP/eboks eller deltageren ringes op, og der sendes ambulant notat til praktiserende læge.

6.1 Arbejdsgang

1. Ved CID-besøget skal forsøgsdeltageren informeres om, at blodprøveresultater ses af læge, og man bliver kontaktet ved behov herfor. Skulle forsøgsdeltageren selv have spørgsmål til prøveresultaterne er de velkomne til at kontakte forsøgs-sitet.
2. Alle prøvesvar gennemgås og signeres af læge i SP.
3. Ved behov for kontakt til patient dokumenteres dette i journal inkl. hvorfor og plan (oftest anbefaling om at søge egen læge), og der sendes kopi af notat til egen læge til orientering.

6.2 Handlegrænser

Nedenfor er beskrevet grænseværdier for faste blodprøver, urinprøve og DXA-skanning som udføres i forbindelse med et LightCOM CID-besøg, hvor resultatet i udgangspunktet bør lede til kontakt til patienten. Abnorme svar vil oftest medføre henvisning til opfølgning ved egen læge (information til forsøgsdeltageren og notat til egen læge).

	Grænseværdi
Glukose	≥7 mmol/l <u>uden</u> kendt diabetes <i>eller</i> ≥15 mmol/l <u>med</u> kendt diabetes
Triglycerid	>8 mmol/l
Hba1c	≥48 mmol/mol <u>uden</u> kendt diabetes <i>eller</i> ≥70 mmol/mol <u>med</u> kendt diabetes
Hæmoglobin	<6,8 mmol/l
ALAT	≥3 x øvre reference
Fib4	≥2,7
Trombocytter	<80
eGFR	<60 ml/min <u>uden</u> kendt nyresygdom
Kreatinin	≥30% stigning <u>med</u> kendt nyresygdom (eGFR <60)
Albumin	<30 g/L
Natrium	<130 mmol/l

Kalium	≤3,0 <i>eller</i> ≥5 mmol/l
Total-calcium og albumin korrigeret calcium	<nedre reference <i>eller</i> >øvre reference
PTH	≥12 nmol/l
25-OH vitamin D	<12 <u>uden</u> forhøjet PTH (PTH <øvre normalgrænse) <25 <u>med</u> forhøjet PTH (PTH >øvre normalgrænse)
TSH	<nedre reference <i>eller</i> >6 uden kendt stofskiftesygdom
Urin albumin/kreatinin ratio	>300
DXA	T-score ≤ -1,0 <u>uden</u> kendt osteopeni/osteoporose (husk derfor at påfør den korrekte diagnosekode i SP, hvis osteopeni/osteoporose konstateres). T-scoren aflæses i L1-L4 (eller dele heraf, dog minimum 2 på hinanden følgende hvirvler), lårbenshalsen og/eller total hofte.

7 CHANGE HISTORY

Rev# / Date	Written/Revised By	Revision Description	Approval
0. Written			
1. Edited			
2.			
Removed / replaced:			